

약제 영양급여의 적정성 평가결과

opicapone 50mg

(온젠티스캡슐 50밀리그램, 에스케이케미칼(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 opicapone 50mg

☐ **효능 효과:**

- 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI) 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동
동요증상을 동반한 파킨슨 증후군 환자에 대하여 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제
(DDCI)의 보조치료제

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2020년 제5차 약제급여평가위원회: 2020년 5월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2020년 2월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자
의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습
니다.

가. 평가 결과

□ 최종 결과

- 제약사가 ■■■■■원/50mg/캡슐 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2020년 제5차 약제급여평가위원회 평가결과

- 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI) 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동동요증상을 동반한 파킨슨 증후군 환자에 대하여 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI)의 보조치료제”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하며 소요비용이 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■■원/50mg/캡슐) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI) 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동동요증상을 동반한 파킨슨 증후군 환자에 대하여 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI)의 보조치료제”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 entacapone 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 COMT inhibitors (Catechol-o-methyltransferase inhibitor)로, “레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI) 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동동요증상을 동반한 파킨슨 증후군 환자에 대하여 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI)의 보조치료제”에 허가받은 약제임.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾ 및 가이드라인⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 레보도파/도파 탈탄산효소 억제제(DDCI) 표준요법으로 증상이 개선되지 않는 운동동요 증상을 동반한 파킨슨 증후군 환자에게 권고됨.
- [위약 및 활성약 대조 3상: BIPARK-1]⁶⁾ 약효 소실기에 운동동요증상을 보이는 30~83세 파킨슨병 환자에서 levodopa의 보조적 요법으로 opicapone 5mg, 25mg, 50mg군, entacapone(levodopa 병용)군, 위약군으로 1:1:1:1 배정하여 14~15주 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 및 활성약 대조, 3상 임상시험 결과,

- 1차 평가 지표인 기저치 대비 off state의 절대적 시간변화량은 opicapone 50mg은 위약 대비 우월⁷⁾($p=0.0015$), entacapone 대비 비열등⁸⁾하였음($p=0.0051$). opicapone 5mg군 및 25mg군은 위약 대비 유의한 차이를 보이지 않음(5mg $p=0.056$, 25mg $p=0.080$).
 - 가장 흔한 treatment-emergent adverse event는 이상운동증으로 entacapone군보다 신청품군에서 더 높은 경향을 보임(위약군 4%(5/121), entacapone군 8%(10/122), opicapone 5mg군 14%(17/122), opicapone 25mg군 8%(9/119), opicapone 50mg군 16%(18/115)). 심각한 이상반응은 위약군 5%(6/121), entacapone군 7%(8/122), opicapone 5mg군 3%(4/122), opicapone 25mg 1%(1/119), opicapone 50mg 3%(4/115)로 유사하게 낮았음.
- [위약 대조 3상: BIPARK-2]⁹⁾ 약효 소실기에 운동동요증상을 보이는 30~83세 파킨슨병 환자를 대상으로 levodopa의 보조적 요법으로 opicapone 5mg, 25mg군, 위약군에 배정하여 14~15주 동안 시행한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 3상 임상시험 결과,
- 1차 평가 지표인 기저치 대비 off state의 절대적 시간변화량은 opicapone 50mg은 위약 대비 우월¹⁰⁾($p=0.008$)하였음. opicapone 25mg군은 위약 대비 유의한 차이를 보이지 않음($p=0.11$).
 - 이중 맹검 종료 후 모든 군을 대상으로 52주 개방 표지 시험 결과, 시험 시작점과 끝점에서의 off state의 절대적 시간변화량은 -18.31분(95%CI, -43.56~6.95)이었음.
 - 이중 맹검 단계에서 가장 흔한 treatment-emergent adverse event는 이상운동증, 변비, 구강건조증임. 이중맹검 단계에서 이상반응 발생으로 인한 중단은 오피카폰 50mg군(17/150, 11.3%)에서 오피카폰 25mg군(5/125, 4.0%)과 위약군(9/136, 6.6%) 대비 빈번하게 나타나며 가장 흔한 중단사유는 이상운동증임. 개방표지 단계에서 32명의 환자(9.1%)가 이상반응발생으로 인해 시험을 중단했으며, 가장 흔한 투여관련 중단사유는 도파민성 반응임(이상운동증, 환각, 기립성저혈압, 파킨슨병 악화)
- 관련 학회¹¹⁾¹²⁾에 따르면 신청품은 레보도파의 약효지속시간이 짧아져 운동 동요 증상이 있을 때 사용되는 보조 치료제로 기존의 동일 기전 약물에 비해 하루 1회 복용이 가능하다는 장점이 있는 약제임.

○ 비용 효과성

- 국내 허가사항, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여 MAO-B 억제제(selegiline, rasagiline), Dopamine 효현제(pramipexole, ropinirole), COMT 억제제(entacapone)를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1일 소요비용은 [REDACTED]원으로 대체약제 가중 1일 소요비용인 [REDACTED]원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 [REDACTED]원/50mg/캡슐임.

○ 재정 영향¹³⁾

- 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁵⁾ 1차년도에 약 ■■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■■억원이 증가할 것으로 예상됨¹⁶⁾.

- 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도에 약 ■■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 50mg은 A7 국가 중 3개국(독일, 이탈리아, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.
- 2) Current Medical Diagnosis and Treatment. 2020.
- 3) Rang & Dale's Pharmacology. 9e. 2020.
- 4) NICE guideline. Parkinson's disease in adults. Published: 19. July 2017.
- 5) EFNS/MDS-ES GUIDELINES. European Journal of Neurology 2013, 20: 5 - 15.
- 6) Ferreira JJ, et al. Opicapone as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson's disease and end-of-dose motor fluctuations: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol 2016; 15: 154 - 65
- 7) $p < 0.05$
- 8) 비열등성 시험은 위약 대비 우월한 경우에만 수행되며 비열등성 한계는 30분임
- 9) Lees AJ, et al. Opicapone as Adjunct to Levodopa Therapy in Patients With Parkinson Disease and Motor Fluctuations A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2017 Feb 1;74(2):197-206.
- 10) $p < 0.05$
- 11) 대한신경과학회()
- 12) 대한퇴행성신경질환학회()
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 14) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 [] 캡슐, 2차년도 [] 캡슐, 3차년도 [] 캡슐
- 15) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가
* 병용약제 비용을 제외한 신청품의약품비만 고려함
- 16) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
신청약제와 대체약제에 병용투여되는 levodopa/DDCI의 투약 비용은 동일하다고 가정하여 병용약제의 비용은 생략함.
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 17) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 [] 캡슐, 2차년도 [] 캡슐, 3차년도 [] 캡슐
- 18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액
* 병용약제 비용을 제외한 신청품의약품비만 고려함